Hjelp! Petter må bestå helsefag eksamen!!

Han trenger ekstra cash til en skikkelig klokke!!

HEA3103 Høst 2025

Oppgave 1: 60 %, oppgave 2: 20 %, oppgave 3: 20 %

Case / situasjon

Sted: Solsiden sykehjem, rehabiliteringsavdeling (3 uker)

Pasient: Åse Olsen, f. 08.08.1933 (92), enke. To barn, fem barnebarn, ti oldebarn.

Diagnoser: Hoftebrudd (operert etter fall); gjentatte urinveisinfeksjoner.

Status: Motivert for trening, vil hjem fort. Ustødig/svimmel, spiser lite, obstipasjon, gjentatte UVI. Nedsatt hørsel (høreapparat), prekestol.

Fra pasientjournal:

- Hygiene: vil klare mest mulig, trenger tilrettelegging/hjelp.
- Fysisk: trenger trening, ustødig/svimmel, glad i tur.
- Psykisk: motivert for å komme hjem.
- Sosial/åndelig: sosial, opptatt av familie, liker musikk.
- Ernæring: dårlig matlyst, spiser lite.

Egen situasjon i oppgave 2: hjemmesykepleie hos pasient med diabetes type 2; lage lunsj ut fra matvarer på bilde (bildet er ikke gjengitt her – svaret følger vanlige diabetesprinsipper).

Oppgaver og eksempelsvar

Oppgave 1

Oppgavetekst: Hvilke tiltak vil du sette i verk for at Åse skal nå sitt mål om å komme hjem så fort som mulig? Begrunn tiltakene faglig.

Eksempelsvar

Innledning

Åse Olsen er 92 år og er på rehabiliteringsavdelingen ved Solsiden sykehjem i tre uker etter at hun ble operert for hoftebrudd etter et fall. Hun er motivert for å trene og vil hjem fort. Samtidig er hun ustødig og svimmel, spiser lite, har forstoppelse og har hatt gjentatte urinveisinfeksjoner. Hun hører dårlig og bruker prekestol. Målet er at Åse skal komme hjem så fort som mulig, og da må hun bli sterkere og tryggere, og vi må unngå komplikasjoner som kan forsinke henne.

Hoveddel

Det viktigste tiltaket er trygg trening. Jeg følger planen fra fysioterapeuten og går korte turer med Åse med prekestolen flere ganger om dagen. Hun er glad i tur, så det bygger på noe hun liker. Fordi hun er svimmel, lar jeg henne sitte litt på sengekanten før hun reiser seg, og jeg går tett ved siden av henne. Jeg sørger for gode sko og at gulvet er ryddig. Jeg observerer om hun blir blek, svimmel eller har vondt, og hvis svimmelheten er ny eller verre, melder jeg til sykepleier. Trening er nødvendig for å få tilbake styrke og gangfunksjon, men et nytt fall kan gi et nytt brudd og stoppe hele rehabiliteringen.

Det andre tiltaket gjelder mat. Åse har dårlig matlyst, men hun trenger protein og energi for at såret skal gro og musklene skal bli sterkere. Jeg spør hva hun liker, tilbyr små måltider ofte og legger til rette for at hun kan spise sammen med andre, fordi hun er sosial. Jeg registrerer hva hun spiser, og hvis inntaket er lite, melder jeg til sykepleier, som kan vurdere næringsdrikk.

Det tredje tiltaket er å forebygge forstoppelse og urinveisinfeksjon. Jeg oppfordrer Åse til å drikke jevnt gjennom dagen og tilbyr mat med fiber, som grovbrød, frukt og grønnsaker. Aktivitet hjelper også magen. Jeg legger til rette for faste toalettrutiner og hjelper henne med intimhygiene der hun trenger det. Forstoppelse gir ubehag og dårligere matlyst, og en ny urinveisinfeksjon kan gi feber, forvirring og økt fallfare. Jeg observerer avføring, urin og tegn som svie, hyppig vannlating eller forvirring, og melder fra.

I stellet lar jeg Åse gjøre mest mulig selv, med hjelp der det trengs. Hun skal klare seg hjemme, så det er viktig å øve på daglige gjøremål som å kle på seg og vaske seg. Jeg sjekker at høreapparatet virker, slik at hun forstår beskjeder og kan være med å planlegge. Hun har rett til medvirkning etter pasient- og brukerrettighetsloven.

Jeg bruker også motivasjonen hennes. Hun er opptatt av familien og liker musikk. Jeg kan snakke om barnebarna, og jeg viser henne fremgangen hun gjør, for eksempel at hun går lenger enn i går. Med Åses samtykke kan familien være med på planleggingen av hjemreisen.

Alt dokumenterer jeg, og jeg gir rapport til sykepleier. Hver uke kan teamet vurdere om hun går tryggere, spiser mer, har normal avføring og er uten infeksjon.

Avslutning

Tiltakene handler om trening, mat og forebygging av forstoppelse og infeksjon, fordi dette er det som kan hindre Åse i å komme hjem. Jeg bygger på motivasjonen og interessene hennes, observerer og rapporterer, og samarbeider med sykepleier, fysioterapeut og familien. Slik får hun best mulig sjanse til å nå målet sitt.

Oppgave 2

Oppgavetekst: Ta utgangspunkt i det vedlagte bildet. Foreslå hvilke matvarer pasienten bør velge til lunsj. Er det noen matvarer som ikke er på bildet som du vil foreslå i tillegg? Begrunn valgene. (Situasjon: hjemmesykepleie, pasient med diabetes type 2.)

Eksempelsvar

Innledning

Jeg er i hjemmesykepleien hos en pasient med diabetes type 2 og skal hjelpe til med lunsjen. Bildet fra eksamenssettet er ikke gjengitt i denne samlingen, så jeg svarer ut fra vanlige matvarer og de kostrådene som

gjelder ved diabetes type 2. På eksamen må man knytte svaret til matvarene på bildet.

Hoveddel

Først spør jeg pasienten hva han eller hun har lyst på, og hva som er vanlig til lunsj. Det er pasienten som skal spise maten, og når pasienten er med å bestemme, er sjansen større for at rådene blir fulgt. Det er også en rett etter pasient- og brukerrettighetsloven. Jeg spør også når pasienten spiste sist og har tatt medisinene, fordi det påvirker blodsukkeret.

Til lunsj foreslår jeg grovt brød eller knekkebrød. Grove kornprodukter har mye fiber, og fiber gjør at sukkeret tas opp langsommere i blodet. Det gir jevnere blodsukker og holder pasienten mett lenger. På brødet foreslår jeg pålegg med mye protein og lite sukker, som egg, makrell i tomat, kylling, mager ost eller cottage cheese. Fisk er bra for hjertet, og personer med diabetes har økt risiko for hjerte- og karsykdom. Til dette passer grønnsaker som tomat, agurk og paprika. Grønnsaker gir fiber og vitaminer uten å påvirke blodsukkeret mye. Som drikke foreslår jeg vann, kaffe eller te uten sukker, eller et glass lettmelk.

Hvis bildet viser søtt pålegg som syltetøy eller sjokoladepålegg, loff, brus eller kaker, foreslår jeg å begrense dette. Slike matvarer gir raske blodsukkerstigninger. Jeg forbyr ikke noe, men forklarer kort hvorfor andre valg er bedre for blodsukkeret.

Hvis noe mangler, kan jeg foreslå å kjøpe inn grove kornprodukter, mer grønnsaker, fisk til pålegg og en frukt som dessert. Hvis pasienten synes det er vanskelig å lage mat, kan ferdigkuttede grønnsaker og enkle pålegg gjøre det lettere. Jeg kan også ta med meg tankene til sykepleier, som kan vurdere om pasienten trenger mer veiledning eller hjelp til innkjøp.

Jeg observerer om pasienten spiser maten, og om det er tegn på høyt eller lavt blodsukker, som tretthet, tørste, svette eller skjelving. Jeg dokumenterer hva pasienten spiste og eventuelle observasjoner.

Avslutning

Lunsjen jeg foreslår, har mye fiber og protein og lite sukker, og den kan gi jevnere blodsukker og bedre helse. Pasienten er med å velge, og jeg forklarer enkelt hvorfor. Siden bildet ikke er gjengitt her, bygger svaret på generelle diabetesråd.

Oppgave 3

Oppgavetekst: Du skal måle blodsukker etter oppgitt prosedyre. Forklar faglig hvorfor prosedyren skal utføres på denne måten. Begrunn ut fra gjeldende retningslinjer for hygiene og smittevern.

Eksempelsvar

Innledning

Jeg skal måle blodsukker hos en pasient etter oppgitt prosedyre. I denne oppgaven forklarer jeg hvorfor hvert steg i prosedyren skal gjøres slik det står. Jeg legger vekt på hygiene og smittevern, og på at målingen skal gi et riktig svar.

Hoveddel

Prosedyren starter med at pasienten vasker hendene med såpe og vann, og at hendene er tørre. Det fjerner mikrober, slik at det blir mindre fare for infeksjon i stikkstedet. Det fjerner også sukker og matrester fra fingrene, som kan gi et feil høyt svar. Varmt vann gir dessuten bedre blodsirkulasjon, slik at det er lettere å få en bloddråpe.

Jeg utfører håndhygiene og tar på hansker. Basale smittevernrutiner sier at vi skal bruke hansker når vi kan komme i kontakt med blod. Hanskene beskytter meg mot blodsmitte og pasienten mot mikrober fra hendene mine. Håndhygiene før og etter hver pasient hindrer at smitte overføres mellom pasienter.

Før målingen sjekker jeg at blodsukkerapparatet virker og at teststrimlene ikke er gått ut på dato. Utløpte strimler kan gi feil verdi, og hvis verdien er feil, kan pasienten få feil behandling.

Jeg stikker på siden av fingertuppen. Der er det mange blodårer og færre nerveender enn midt på, så det gjør mindre vondt. Vi bytter finger fra gang til gang, slik at huden ikke blir sår og hard. Lansetten skal bare brukes én gang, fordi den kan overføre smitte og blir sløv.

Den første bloddråpen tørker jeg bort, og jeg bruker den andre. Den første dråpen kan inneholde vevsvæske og rester fra huden, som kan gi et feil svar. Jeg presser ikke hardt på fingeren, fordi det også kan presse ut vevsvæske og gi feil verdi.

Etter målingen legger jeg en tørk på stikkstedet. Lansetten kaster jeg med en gang i en gul kanyleboks. Det forebygger stikkskader og blodsmitte hos meg og andre. Brukt utstyr og hansker kastes etter rutinene, og jeg utfører håndhygiene igjen.

Til slutt dokumenterer jeg verdien, tidspunktet og om pasienten hadde spist. Blodsukkerverdien er viktig for sykepleier og lege når de vurderer behandlingen. Hvis verdien er uvanlig høy eller lav, melder jeg fra med en gang. Jeg forklarer også pasienten hva jeg gjør, slik at han eller hun er med og kan lære å måle selv.

Avslutning

Hvert steg i prosedyren har en grunn. Noen steg skal forebygge smitte for både pasient og helsepersonell, og andre skal sikre at svaret blir riktig. Når jeg følger prosedyren nøyaktig, gir jeg forsvarlig helsehjelp slik helsepersonelloven krever.

Eksempelsvar til øving, skrevet med sikte på et nivå mellom karakter 4 og 5. Uoffisielt – ikke en karaktergaranti eller offisielt fasitsvar.